



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : امال على احمد على

العنوان : اسبيكوا 8م 2 المقطم
القاهرة

الحي / المدينة : المقطم

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

رقم البطاقة : 26602080102184 رقم التليفون : 01050778865

العمر (تاريخ الميلاد) : 08-02-1966 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج الالم ومضادات القئ لمرضي
الاورام المنتشر [14456]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----
قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: امال على احمد علي National ID: 26602080102184	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Pin Medication And Anti Emetics
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

رقم التليفون: ١١٩٦-٨٨٩٥
الرقم القومي: ١١٩٦-٨٨٩٥
الاسم: أحمد محمد
التاريخ: ١١/١١/٢٠٢٤

[illegible]

قياس ضغط	12/8	قياس السكر	100	مؤشر كتلة الجسم	108	الوزن	108
----------	------	------------	-----	-----------------	-----	-------	-----

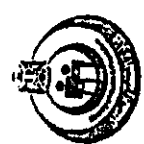
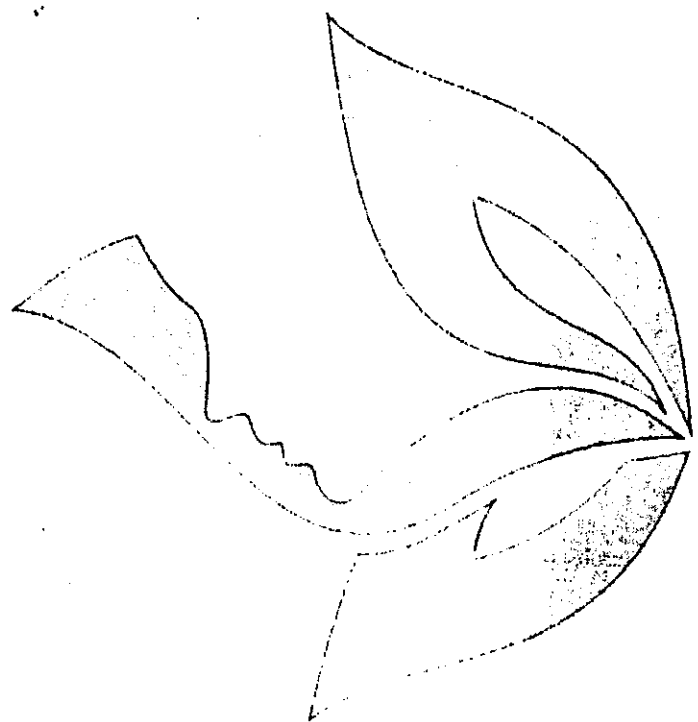
مفكرى لمسك
رأى بموعد الفحص الذاتي شهرانيا

2019	سپتامبر		2019	سپتامبر		2019	یوگنیو
2019	دسامبر		2019	دسامبر		2019	اکتوبر
2020	مارس		2020	مارس		2020	یونیو
2020	یوگنیو		2020	یوگنیو		2020	اپریل
2020	سپتامبر		2020	سپتامبر		2020	یوگنیو
2020	دسامبر		2020	دسامبر		2020	اکتوبر
2021	مارس		2021	مارس		2021	یونیو
2021	یوگنیو		2021	یوگنیو		2021	اپریل

موعده التقويمية .
 توقيعه الطبيب ،
 موقعة على الأملص ، ولزيادة نسب الشفاء .
 موعده الفحص القادم :
 المحان المحولة له بالوقت .

15335

10 million shareholders



منظمة
الصحة العالمية

महाराष्ट्र
सर्वोच्च न्यायालय
मुंबई

Name: Mrs. Amal Ali Ahmed Ali

Date: 6/6/2026

ID:2226018799

Acc.:5260419

Referring: Al-Mahd Elqawmy Awram

Digital 3D soft tissue mammography & tomosynthesis with ultrasound examination of both breasts, revealed:

Indication: left breast palpable lump

Mammography & Tomosynthesis:

- Scattered fibroglandular densities (ACR-b)
- **Left breast:** Retro-areolar irregular shaped indistinct margin heterogeneous dense lesion, non-parallel orientation, reaching the nipple with subsequent nipple and skin retraction measuring 5.7 x 3.7 cm. The lesion is more conspicuous by tomosynthesis
- **Right breast:**
 - Normal breast parenchyma with no gross evidences of dense spiculated masses or architecture distortion seen.
 - No suspicious micro-calcific clusters noted.
 - Normal skin thickness and contour. Normal areola / nipple complex.

Ultrasonographic examination showed:

- Homogeneous breast parenchyma –predominantly fatty
- **Left breast:**
 - Retro-areolar irregular shape indistinct margin heterogeneous hypoechoic solid lesion, non-parallel orientation, posterior shadowing measuring 5.5 x 3.4 cm in average diameter, prominent internal vascularity of low resistance arterial waveform. Pattern in complementary color Doppler.
 - The lesion is involving the nipple and related skin with prominent vascularity.
 - More than three level I axillary lymph nodes with cortical thickness up to 0.46 cm.
- **Right breast:**
 - No gross evidence of suspicious cystic or solid masses.
 - No retro-areolar dilated ducts noted.
 - Normal skin thickness & contour. Normal nipple/areola complex.
 - Non-specific axillary lymph nodes with preserved oval shaped and central echogenic hilum.

Name: <u>امال على احمد على</u>		
MR. : <u>12191</u>		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 60-year-old individual with a positive family history of breast cancer in the mother and comorbidities including two percutaneous coronary interventions on aspirin therapy and hypertension. The clinical history is notable for a left-sided invasive ductal carcinoma, grade 2. Core needle biopsy of the left breast revealed invasive ductal carcinoma, grade 2. Immunohistochemistry showed estrogen receptor 8/8, progesterone receptor 5/8, HER2 expression 10 %, and Ki-67 proliferation index 20 %. Sonomammography performed on 6/6/2026 demonstrated a retro-areolar irregular heterogeneous dense lesion measuring 5.7 × 3.7 cm, extending to the nipple with associated nipple and skin retraction, and more than three level-1 lymph nodes with cortical thickness of 0.46 cm. Staging imaging included a CT chest-abdomen-pelvis on 22/7/2026, which identified a few mediastinal lymph nodes and scattered vertebral sclerotic foci, and a PET-CT on 2/8/2026 that showed increased FDG uptake in mediastinal nodes (superior mediastinal, paratracheal, subcranial, post-mediastinal, and hilar) as well as variable-grade FDG-avid sclerotic lesions in lumbar vertebra 4 and the left acetabulum (SUVmax 8.1). The referring team recommended initiation of an aromatase inhibitor for three months with reassessment by PET-CT. The multidisciplinary team concurred and the plan is to start the aromatase inhibitor for three months followed by PET-CT reassessment.		
تحريراً في ,		
	التاريخ :	23-09-2026
	الوقت :	
	الطبيب المعالج :	
يعتمد ,		

Name: Mrs. Amal Ali Ahmed Ali

Opinion:

- **Right breast:** normal study (**BIRADS 1**).
- **Left breast:** retro-areolar locally advanced pathological lesion as described (**BIRADS 5**).

Recommendation:

- Ultrasound guided biopsy from the left breast lesion.

Dr. Lamiaa Elsharkawy, MD

Printed: GH. 5. 06/06/2014 4:48:11 PM

BI-RADS scoring is the breast imaging and reporting data system for classifying the radiological diagnosis of breast lesions:

- **BI-RADS 0:** Incomplete - need additional imaging evaluation or comparison with previous films.
- **BI-RADS 1:** Normal examination - nothing to comment on - Routine mammography screening is recommended.
- **BI-RADS 2:** Benign findings - routine mammography screening is recommended.
- **BI-RADS 3:** Probably benign <2% malignancy - short interval follow-up is suggested.
- **BI-RADS 4:** Suspicious >2 but <95% - Biopsy should be considered.
 - **4A:** low suspicion of malignancy: 2-20%.
 - **4B:** Mod suspicion of malignancy: 10-50%.
 - **4C:** High suspicion of malignancy: 50-90%.
- **BI-RADS 5:** Highly suspicious of malignancy >95% - appropriate action should be taken.
- **BI-RADS 6:** Known - biopsy proven malignancy. Surgical excision when clinically appropriate.

American college of radiology (ACR) scoring of breast density:

- **ACR. a:** almost entirely fatty.
- **ACR. b:** scattered areas of fibro-glandular density.
- **ACR. c:** heterogeneously dense.
- **ACR. d:** extremely dense.


 وزارة الداخلية
 بطاقة تحقيق الشخصية

أمال
 دةلى احمد على
 اسبيكو اب ٨ م
 المقطم - القاهرة

٢٦٦٠٢٠٨٠١٠٢١٨٤
 II5154904

٢٠٢٠/٠٢ ٢٦٦٠٢٠٨٠١٠٢١٨٤
 ربة منزل
 أنثى
 مسجلة
 أرملة

البضاعة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٢/٠٨





Patient Name	الحاجة/ امال على احمد على	Patient ID.	1 026032 810294
Age / Sex	60 Years / Female	Request Date	28-Mar-2026 10:05 AM
Referred By	عيادة الباطنة	Printed In	28-Mar-2026 11:26 AM

BIOCHEMISTRY REPORT

Lipids Profile:

Reference Range :

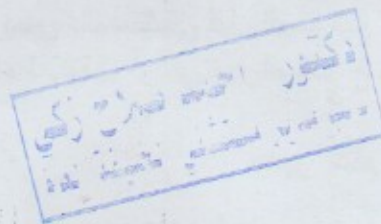
▲ Serum Cholesterol	:	214 mg/dL	N: 180 - 220 mg/dL
▲ Serum Triglycerides	:	230 mg/dL	Female 35 - 135 mg/dL

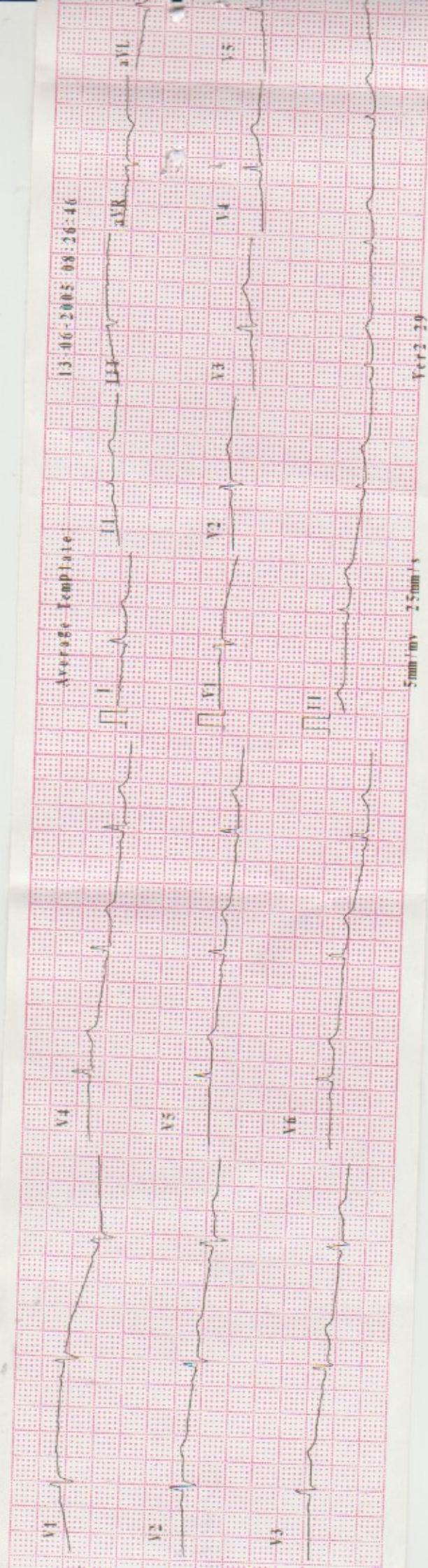
Doctor's signature:

N. M. El-Sayed
Thanks

$$\frac{165}{100}$$

معتد





إسم المريض ثلاثي: احمد علي الخ
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من بشأن تقرير طبي للمريض:

بقسم رقم طبي

تنتشر ف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

صالح - طاهر باليد

صالح بالحمد والصبر

صالح من علاج الج

تحريراً في

التاريخ: ١٤/١٢/٢٠٢٢

الوقت:

الطبيب المعالج
د. محمد

يعتمد،،